EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	: HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	: 83129
SERVICIO	: MEDICINA HSC		
FECHA	: 2024-04-24 09:20:00		

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: GUILLERMO ANDRES CARO ECHEVERRIA			RUN	: 10.549.922-1
F.Nac	: 24-07-1966	Edad	: 57 AÑOS, 9 MESES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-04-23	Fecha Egreso	: 2024-04-24 09:20:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Insuficiencia Respiratoria aguda Resuelta
-¿Edema pulmonar? Resuelto
-Insuficiencia cardiaca descompensada
-¿IRB?
- Neumonía Derecha

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente Masculino Con Antecedentes Mórbidos: HTA, DMT2, ERC en HD, ACV previo, DLP. SIN Alergia Conocidas. refiere inicio de sintomatología el domingo 21/04 presentando dificultad para respirar a moderados y leves esfuerzos. Acorde a relato, asociado a accesos de tos intermitente leve a moderado, húmedo, expectoración no visualizada. Para ayer 22/04, acude a sesión de HD donde toman signos vitales destacando desaturación. Por compromiso general se deriva a este centro para soporte posterior a término de sesión de HD, considerando posibilidad de congestión pulmonar.
Se toman exámenes paraclínicos de ingreso que reportan:PCR 50,6, LEU 11,90, DIMERO 1,060, GSA-> PH 7,54, PCO2 36,6, PO2 62,3, HCO3 31,4, SAT 89, FIO2 21%, pafi 297.
Se toman imágenes que evidencian: RX TX con franco infiltrado a predominio derecho, cardiomegalia++. TC de TX con informe incongruente con imagen. Se solicita adendum de TC. Reporta Neumonía Multifocal De predominio derecho, CARDIOMEGALIA, Escaso derrame Pleural Pericartdico. ATEROMATOSIS Aortica . En vista de condiciones y requerimiento de O2, se decide ingreso a servicio de medicina. Con tto depletivo – atb- broncodiladodores evidenciado mejoría clínica, sin requerimeinto de oxigeno, sat 95% ambiental Ex físico yugulares plans, Piel: cambios y signos propios de la edad, palidez cutáneomucosa generalizada, Torax simétrico, RSRSPS, mp presente . Escasos crepitos predomino derecho. RSCSRSRS, Abdomen RHA, sin megalias , blanmdo, neurologico vigil orientado glagsow 15 ptos sin focalización neurológica.
En condiciones de Alta para continuar tto con HODOM.

PLAN DE MANEJO:

HODOM
Pendiente panel viral
Mantener atb
Kine respiratoria

INDICACIONES AL ALTA

1. Hodom
2. Regimen Liviano Restricción Hídrica 800 Cc Dia
3. Kine Respiratoria 1 Vez
4. Pendiente resultado PANEL VIRAL
5. Ceftriaxona Frasco 1 Gramo 2 Frasco Cada 24 Hrs. Por 5 Dias Via Endovenosa
6. Hidrocortisona Frasco Ampolla 100 Miligramos 1 Frasco Ampolla Cada 24 Hrs. Por 5 Dias Via Endovenosa
7. Losartan Potasico Comprimido 50 Miligramos 1 Comprimido Cada 12 Hrs. Por 30 Dias Via Oral
8. Carvedilol Comprimido 25 Miligramos 0.5 Comprimido Cada 12 Hrs. Por 30 Dias Via Oral
9. Omeprazol Comprimido 20 Miligramos 1 Comprimido Cada 24 Hrs. Por 30 Dias Via Oral
10. Isosorbida Dinitrato Comprimido 10 Miligramos 1 Comprimido Cada 8 Hrs. Por 30dias Via Oral
11. Fluticasona/Salmeterol Inhalador 250 Microgramos / 25 Microgramos 2 Puff C 12hrs por 10 dias
12. Ipratropio Inhalador Frasco Unidad 4 Puff C 6hrs por 7 dias
13. Salbutamol Inhalador 100 Microgramos / Dosis 2 Puff C 8hrs por 7 dias
14. Furosemida 20 Miligramos / Minilitros 1 Ampolla Cada 12 Hrs. Por 5 Dias Via Oral

EXÁMENES Y RESULTADOS

Fosfatasa Alcalina : 89 U/L 38 - 126
Bilirrubina Indirecta : 0,35 mg/dL < 1,10
Bilirrubina Directa : 0,25 mg/dL < 0,30
Bilirrubina Total : 0,60 mg/dL 0,20 - 1,30
ASAT/GOT : 15 * U/L 17 - 59
ALAT/GPT : 19 U/L < 50
Gama GT : 32 U/L 15 - 73
LDH : 178
Sodio (Na) : 135,00 mmol/L 135,00 - 145,00
Potasio (K) : 4,50 mmol/L 3,50 - 5,50

Cloro (Cl) : 94,00
Lactato : 1,5
Proteina C Reactiva : 50,6

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3

JEFE SERVICIO